검진병원	메디피움 판교
검진일자	2024-05-09
생년월일	19921103
성명	최진원
회사명	카카오
부서명	

CareLink에서의 결과조회는 검진병원에서 CareLink에 제공한 검진결과 데이터를 바탕으로 구성됩니다. 실제 검진병원에서 제공하는 검진결과 표(지면)의 내용과 검사항목, 검사수치, 참고치 등에 차이가 있을 수 있으므로 단순 참고용으로만 보시기 바랍니다.

건강검진의 필요성

사람은 누구나 건강하게 오래 살기를 원합니다. 현재 우리는 어느 질병이든 조기에 발견하면 완치될 수 있는 최첨단 의학 시대에 살고 있지만, 우리 몸의 어느 부분에 문제가 발생했을 때 병원을 찾는다 면 질병을 치료하는데 많은 비용과 시간이 걸리는 것을 감안해야합니다. 건강검진이란 것은, 건강한 사람일수록 꾸준하게 자신의 건강을 관리함으로써 건강을 지킬수 있는 자기관리 방법입니다. 그러므로 정기적인 건강검진을 통하여 자신의 건강상태를 잘 인지하고 지속적인 건강관리를 실천함으로써 더욱 활기찬 삶을 도모할 수가 있으며, 질병을 조기 진단하여 효과적인 치료와 예방하는 것이 본인과 가족 모두의 행복을 보장하는 것입니다

종합 소견

※ 위내시경 검사

- 위식도 역류질환, 만성 표재성 위염 소견이 관찰됩니다. 1년 후 추적검사 바랍니다.

위식도 역류질환은 위 내용물이 식도로 역류하여 불편한 증상을 유발하거나 이로 인하여 합병증을 유발하는 질환을 말합니다. 가슴쓰림, 신물, 소화불량, 흉통, 삼킴곤란, 후두염 등 증상이 동반된 경우 약물치료가 필요하며, 기름진 음식, 커피, 술, 초콜릿, 야식 등을 피하고 적절한 운동으로 체중관리 하는 것이 도움이 됩니다.

만성 표재성 위염은 대표적인 만성 위염 중 하나로, 위 점막에 한하여 발생하고 그 증상이 심각하지 않으며 주로 30대 이상의 성인에게서 많이 나타납니다. 자극적인 음식, 음주 및 스트레스가 가장 큰 원인이며, 초기에는 그 증상이 잘 나타나지 않지만, 질환이 진행되게 되면 복부팽만감이나 명치 통증, 식욕부진 등의 증상이 동반될 수 있습니다.

※ 대장내시경 검사

- 대장 정결이 다소 불량하여 부분적 불완전 검사가 진행되었으며, 보이는 범위 내 특이 소견은 보이지 않습니다. 1-2년 후 추적검사 바랍니다.

※ 상복부초음파 검사

- 상복부 초음파(간, 담낭, 비장, 췌장, 신장) 검사 결과 특이소견 없습니다.

※ 안과 검사

- 안저검사 결과 정상범주 소견으로 이상소견이 보이지 않았습니다.

◎ 안저 검사는 눈의 심부 쪽에 있는 망막과 시신경의 건강상태를 보기 위해 망막사진을 찍는 검사 입니다. 그러나 검진에서 시행하는 안저검사는 동공확대(산동) 없이 시행하기 때문에 검사상에 제한이 있을 수 있습니다. 매체의 혼탁이 심할 때(백내장, 유리체혼탁, 유리체출혈 등)는 안저 검사가 불가능하며 특히 당뇨나 안과적 질환이 있는 경우, 산동없이 시행된 검사만으로는 충분하지 않을 수 있으니 정기적으로 안과 진료 받으시기 바랍니다.

※ 일반 간기능 검사

- 혈액 검사 결과 총, 간접 빌리루빈(Total Bilirubin: 1.3 mg/dL, Indirect bilirubin: 0.9 mg/dL) 증가 소견입니다. 정기적인 추적검사 바랍니다.

간, 담도계통 이상 또는 용혈이 있을 때 증가하며, 정상에서도 효소부족으로 인해, 오랫동안 금식을 하거나 열성질환이 있을 때 일시적으로 증가하는 경우도 있습니다.
- 혈액 검사 결과 혈청지피티(sGPT: 47 U/L) 증가 소견입니다. 추적관찰 위해 내과 진료 바랍니다.

이는 주로 간세포 내에 존재하는 효소로 급만성 바이러스성 간염, 지방간, 간경화, 간암 등 간질환 및 약물 복용, 음주, 심한 운동시 증가될 수 있습니다.

※ 간염 검사

- A형 간염 항체가 생성되어 예방접종이 필요하지 않습니다.

- B형 간염 항체가 생성되어 예방접종이 필요하지 않습니다.

- C형 간염 바이러스 항체검사 결과 음성(정상)입니다.

※ 관절질환 검사

- 혈액 검사 결과 류마티스 인자(RA Factor: 37 U/mL) 양성 소견입니다.

이는 류마티스 관절염의 진단 및 추적관찰을 위한 검사이나 관절염 이외의 염증, 자가면역질환 또는 면역학적 검사상 교차반응, 정상인(~10%) 및 노인(~25%)에서도 양성반응을 보일 수 있습니다. 조조강직, 관절부종, 관절통증 등의 증상이 있으시면 류마티스내과 진료 권합니다.

- 혈액검사 결과 고요산 혈증(Uric acid: 8.8 mg/dL) 소견입니다.

신부전, 통풍 또는 이뇨제 장기 복용 시 상승할 수 있으며 고지혈증, 비만, 당뇨병, 동맥경화증 및 고혈압 등의 질병과 과음, 고단백식, 운동부족과도 연관이 있습니다. 요산 수치가 상승되어 있어도 관절통 증상이 없으면 무증상의 고요산혈증으로 특별한 약물치료는 필요 없지만, 일단 관절통이 발생되면 재발이 자주 발생하므로 적극적으로 치료해야 합니다.

◎ 식이요법
① 내장육류, 정어리, 고등어, 청어, 가리비조개, 생선알 등 퓨린 함량이 많은 식품을 피하십시오.
② 물을 충분히 섭취하십시오.
③ 술을 삼가고 맥주의 섭취는 더욱 주의하십시오.
④ 기름기가 많은 음식을 제한하십시오.(튀김, 부침, 땅콩, 호두, 잣, 버터 등)

※ 소변 검사

- 소변 검사 결과 케톤체(U. Keton: 양성(+1)) 소견입니다.

이는 장시간의 절식으로 인한 공복상태, 발열, 구토, 장기간의 설사 등의 증상에서 나타날 수 있으며 당뇨인 경우 인슐린 분비저하로 인한 고혈당으로 혈당조절이 불안정할 때나 드물게는 갑상선 기능항진에서 검출되기도 합니다.

이 외 임상적으로 문제 되지 않는 소견과 정상 소견은 언급하지 않았습니다.
검사 결과 상 약간의 수치 이상이 있는 경우라도 단독 검사만으로 의미가 없거나, 금식으로 인해 영향 받은 것으로 보일 경우 의학적으로 큰 문제가 되지 않아 종합소견에 언급하지 않았습니다. 앞으로도 귀하의 지속적인 건강관리를 위해 적어도 연 1회 주치의와의 상담 및 정기검진을 권유드립니다.

◇ 건강검진 결과표 참고사항 (결과 수치 색 표기)
▶검정색 : 정상
▶붉은색 : 임상 기준치 이상
▶파랑색 : 임상 기준치 이하

기초 검사

신체계측 및 혈압검사

비만은 체내에 지방이 과다하게 축적된 상태를 말하며, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 지방간, 뇌혈관질환 등의 만성질환을 유발할 수 있으므로 적절한 관리가 필요합니다.

혈압은 활동상태, 안정상태등에 따라 수시로 변동하므로 한번의 측정으로 고혈압을 진단하기는 어렵습니다. 충분히 안정을 취한 후 혈압을 측정하고 정기적으로 측정하는것을 권장합니다.

관련 질환 비만, 고혈압, 저혈압

검사항목	2024	참고치
신장 (cm)	176.2	
체중 (kg)	70.2	
체질량지수 (BMI)	22.6	18.5~22.9
허리둘레(복위) (cm)	80	90 미만
수축기혈압 (mmHg)	110	120 미만
이완기혈압 (mmHg)	67	80 미만

안과 검사

안저검사는 눈의 안쪽 구조물을 직접 촬영하는 검사이며, 안압검사는 눈 안쪽의 압력을 측정하는 검사입니다. 안저 및 안압검사는 고혈압성 또는 당뇨병성 망막질환이나 시신경 이상유무, 녹내장, 백내장, 등을 검사할 수 있습니다.

관련 질환 근시/원시, 녹내장, 백내장, 망막질환 등

검사항목	2024	참고치
교정시력(좌)	1.0	
교정시력(우)	1.2	
안압(좌) (mmHg)	13.3	10-21

안압(우) (mmHg)	13.4	10-21
안저	정상	

청력 검사

청력검사를 통해 청력손실의 유무와 정도를 평가할 수 있으며, 40dB 이상일 경우 일상생활에 지장이 있을 수 있으며, 수치가 커질수록 난청의 위험이 있습니다.

관련 질환 청력장애

검사항목	2024	참고치
청력좌(500Hz) (dB)	35	0-30
청력우(500Hz) (dB)	35	0-30
청력좌(1000Hz) (dB)	35	0-30
청력우(1000Hz) (dB)	35	0-30
청력좌(2000Hz) (dB)	35	0-30
청력우(2000Hz) (dB)	35	0-30
청력좌(4000Hz) (dB)	35	0-30
청력우(4000Hz) (dB)	35	0-30

심폐기능 검사

심전도 검사

심전도는 심장의 전기적 활동 상태를 그래프로 기록한 검사입니다.
부정맥, 협심증, 심근경색 등의 허혈성 심장병의 발견 및 진단에 도움을 주며, 증상에 따라 전문의의 진료가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 심비대, 부정맥, 심근경색 등

검사항목	2024
심전도 검사	정상

흉부X선 검사

흉부 X선 촬영은 폐부위, 심장, 종경동, 횡격막 등의 이상을 검사하기 위해 촬영하게 되며, X선 투과방향에 위치하는 구조물들이 겹쳐보여 병변의 판독이 어려울 경우 CT 등의 추가 검사가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 폐 및 흉부질환

검사항목	2024
흉부X선 촬영	정상

간기능 검사

간기능은 간질환, 약물복용, 음주, 비만 등에 의해 변화될 수 있습니다.
빌리루빈의 증가는 간질환, 황달 등과 관련 있지만 공복시 단순 증가할 수 있으며, 총단백 및 알부민의 변화는 간질환, 신장질환 등과 관련이 있을 수 있습니다.

관련 질환 급·만성간염, 지방간, 알콜성간장애, 황달, 간경변증

검사항목	2024	참고치
총단백(Total protein) (g/dL)	7.5	5.8-8.3
알부민(Albumin) (g/dL)	4.8	3.1-5.3
글로블린(Globulin) (g/dL)	2.7	2.0-3.5
A/G비율	1.8	1.0-2.3
총빌리루빈(Total bilirubin) (mg/dL)	1.3	0.2-1.4
직접빌리루빈(Direct bilirubin) (mg/dL)	0.4	0-0.4
간접빌리루빈(Indirect bilirubin) (mg/dL)	0.9	0-0.8
AST(SGOT) (IU/L)	36	0-40
ALT(SGPT) (IU/L)	47	0-40
³GTP (IU/L)	16	5-63
알칼리성 인산가수 분해효소(ALP) (IU/L)	160	30-130
유산탈수소효소(LDH) (U/L)	161	100-497

간염표지자 검사

간염표지자 검사는 바이러스성 간염에 대한 검사입니다.

A형 간염 항체(HAV Ab)와 B형 간염 표면항체(HBs Ab)가 양성인 경우는 면역이 있는 것을 의미하므로 예방접종을 맞으실 필요가 없습니다.

B형 간염 항원(HBs Ag) 양성인 경우는 바이러스 보균 상태를 의미하고, B형 간염 항원/항체 모두 음성인 경우는 예방접종을 권유합니다.

C형 간염 항체(HCV Ab)양성인 경우는 과거감염 또는 현재 보균 상태일 수 있으므로 추가검사가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 간염

검사항목	2024	참고치
HBs Ag(B형 간염 바이러스 항원)	0.24	음성
HBs Ab(B형 간염 바이러스 항체)	13.14	
HCV Ab(C형 간염 바이러스 항체)	음성	음성

일반 혈액 검사

일반혈액 검사는 혈액 내 존재하는 세포(적혈구, 백혈구, 혈소판 등)의 특성을 분석하는 검사로 전반적인 건강상태를 나타내며, 질환의 선별검사와 추적검사로 이용됩니다. 일반적으로 혈액질환, 빈혈, 적혈구 증가증, 백혈병,혈액응고이상 등의 여부를 살펴볼 수 있습니다.

관련 질환 급·만성염증, 빈혈, 출혈성질환, 기타혈액질환, 각종백혈병, 알레르기질환

검사항목	2024	참고치
적혈구수(RBC) (x10^6/uL)	5.49	4.0-6.3
혈색소(Hb) (g/dL)	16.7	13-18
적혈구용적(Hematocrit) (%)	49.7	38-53
평균적혈구용적(MCV) (fl)	90.5	80-100
평균적혈구혈색소량(MCH) (pg)	30.4	27-34
평균적혈구혈색소농도(MCHC) (g/dL)	33.6	31-38
적혈구분포계수(RDW) (%)	11.8	11.5-15.5
혈소판수(PLT) ($x10^3$/uL)	272	130-400
혈소판백분율(PCT) (%)	0.240	0.15-0.32
평균혈소판용적(MPV) (fl)	8.7	7.4-12.0
혈소판분포폭(PDW) (fl)	9.0	10.0-18.0
백혈구수(WBC) ($x10^3$/uL)	3.9	4.0-11.0
분획호중구(Seg.Neutrophil) (%)	52.7	40-75
임파구(Lymphocyte) (%)	32.7	15-45
단핵구(Monocyte) (%)	10.5	0-11
호산구(Eosinophile) (%)	3.6	0-7
호염기구(Basophile) (%)	0.5	0-2

종양표지자 검사

종양표지자 검사는 혈액을 통해 간접적으로 암의 유무를 평가하는 검사로, 진단적 가치보다는 치료효과의 판정, 재발유무를 평가하는데 도움이 될 수 있습니다.

관련 질환 간암, 간경변, 대장암, 직장암, 폐암, 전립선암, 비대증, 난소암, 췌장암, 간담도계암, 백혈병

검사항목	2024	참고치
AFP (ng/mL)	1.69	0-20
CEA (ng/mL)	1.17	0-6
PSA (ng/mL)	0.30	0-4
CA19-9 (U/mL)	2.44	0-37

철 결핍성 빈혈 관련 검사

빈혈관련 검사는 체내 철분 저장 정도를 평가하는 검사입니다.
철결핍성 빈혈에서 혈중 철분 및 Ferritin은 감소하고 TIBC는 증가되며, 최소 3개월 이상 철분제제나 철분이 풍부한 식이를 권장합니다.

관련 질환 철결핍성빈혈, 만성질환에 의한 빈혈

검사항목	2024	참고치
혈청철(Fe) (μg/dL)	106	49-182
불포화 철결합능(UIBC) (μg/dL)	182	130-300
총결합능(TIBC) (μg/dL)	288	240-457

신장기능/감염성 검사

신장기능 검사

신장은 체내 노폐물을 배출하는 중요한 기능을 하며, 요소질소와 크레아티닌의 증가는 신장기능 저하를 의심할 수 있습니다.

관련 질환 신부전증, 신장기능장애

검사항목	2024	참고치
요소질소(BUN) (mg/dL)	10.9	5-26
크레아티닌(Creatinin) (mg/dL)	1.07	0.3-1.5
B/C비율	10	

소변 검사

소변검사는 신장, 방광, 요도의 질환을 진단하기 위한 검사입니다.
주로 혈뇨 및 요로 감염여부를 평가할 수 있으며, 단백뇨의 경우 신장기능 저하를 의심할 수 있습니다.

관련 질환 방광염, 요도염, 요로결석, 당뇨병, 황달

검사항목	2024	참고치
요백혈구 (urine Leukocytes)	음성	
요아질산(urine Nitrite)	음성	
요비중(urine S.G)	1.025	1.005-1.035
요산도(urine pH)	5.0	5.0-8.0
요단백(urine protein)	음성	
요당(urine glucose)	음성	
요케톤체(urine ketone body)	양성(+1)	
유로빌리노겐(urobilinogen)	약양성	
요빌리루빈(urine bilirubin)	음성	

요잠혈(urine occult bood)	음성	
요침사(WBC)	0-5	0-3
요침사(RBC)	0-3	0-3
요침사(상피세포)	0-3	0-3

전해질 검사

전해질은 체내 산염기의 균형에 중요한 역할을 하며, 전해질의 농도를 측정하여 주로 뼈질환, 신장질환, 내분비질환, 심장질환 등을 진단할 수 있습니다.

관련 질환 전해질대사, 부갑상선 질환

검사항목	2024	참고치
나트륨(Na) (mEq/L)	140.0	135-155
칼륨(K) (mEq/L)	4.00	3.5-5.5
염소(Cl) (mEq/L)	102.0	95-110
칼슘(Ca) (mg/dL)	9.3	8.3-11.0
인(P) (mg/dL)	3.0	2.5-5.6

성인병 및 대사관련 질환

지질대사 및 심혈관계 검사

총콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 중성지방의 증가는 심혈관계질환의 위험이 있으므로 기준치 이하로 유지해야 되며, 반대로 HDL콜레스테롤은 심혈관질환 예방 효과가 있어 기준치보다 높게 유지해야합니다.
고지혈증을 예방하기 위해서는 식이요법과 운동요법이 매우 중요합니다.
아포지단백 A-1의 증가시 동맥경화 예방에 효과적이므로 높게 유지하는것이 좋으며, 아포지단백 B의 증가시 비만, 동맥경화, 당뇨병의 위험이 있으므로 낮게 유지하는 것이 좋습니다.

관련 질환 심근경색증, 동맥경화증, 고지혈증

검사항목	2024	참고치
크레아티닌키나제(CPK) (U/L)	68	30-250
총콜레스테롤(Total cholesterol) (mg/dL)	157	200 미만
HDL-콜레스테롤(HDL-cholesterol) (mg/dL)	41	40 이상
LDL-콜레스테롤(LDL-cholesterol) (mg/dL)	103	130 미만
중성지방(Triglyceride) (mg/dL)	61	200 미만

췌장기능 검사

췌장은 소화효소와 호르몬을 분비하는 기관으로 췌장염시 혈중 아밀라제가 상승합니다.

관련 질환 췌장염

검사항목	2024	참고치
아밀라제 (IU/L)	37	28-110

당뇨 검사

· 공복시혈당은 당뇨병을 검사하는 가장 기본적인 지표로 사용되며, 8시간이상 금식 후 측정한 결과로 진단합니다. 정상에서 공복혈당은 110mg 미만으로 유지되며, 110-125mg/dL 인 경우는 당뇨병 전단계(공복혈당 장애), 126mg/dL 이상일 경우 당뇨병으로 진단됩니다.

· 당화혈색소는 2~3개월 동안의 평균적인 혈당조절상태를 나타내는 검사로 정상에서 5.7%미만으로 유지되며, 5.7-6.4%인 경우 당뇨병 전단계, 6.5%이상일 경우 당뇨병으로 진단됩니다.

관련 질환 당뇨병, 공복혈당장애

검사항목	2024	참고치
공복시혈당(FBS=Glucose) (mg/dL)	81	70-110

갑상선 및 내분비 관련 질환

갑상선 기능 검사

· TSH는 갑상선의 기능변화를 반영하는 가장 좋은 검사법으로 갑상선의 기능이 저하되면 증가되고, 갑상선의 기능이 항진되면 감소합니다.

· Free T4 감소는 갑상선 기능 저하증을 의심할 수 있으며, 증가시에는 갑상선 기능 항진증을 의심할 수 있습니다.

관련 질환 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증

검사항목	2024	참고치
갑상선자극호르몬(TSH) (uU/mL)	2.23	0.25-5.50
자유 갑상선 호르몬(FreeT4) (ng/dL)	1.55	0.8-1.9

통풍 및 염증반응 검사

· 요산은 주로 신장에서 여과되어 소변으로 배출됩니다. 요산의 생성증가나 배설 장애가 있는 경우 혈액에 축적되어 통풍, 신장 및 요로결석의 원인이 되기도 합니다.

· RF, HS-CRP, ESR검사는 전신 염증상태를 반영하는 지표입니다. RF는 류마티스 관절염에서 양성으로 나타날 수 있으나 증상이 없는 경우 큰 의미는 없습니다. CRP, ESR 상승은 감염, 자가면역질환과 악성종양 등에서 나타나지만 비염증성 질환에서 상승되기도 하므로 의사와 상의가 필요합니다.

관련 질환 통풍, 류마티스, 염증성질환

검사항목	2024	참고치
요산(uric acid) (mg/dL)	8.8	3.0-7.0
류마티스인자(RF) (IU/mL)	37	15 미만
HS_CRP (mg/dL)	0.09	0.6 미만

골밀도 검사

골밀도 검사는 인체 특정 부위의 뼈의 밀도를 측정하는 검사입니다.
지나친 음주, 흡연, 운동부족, 칼슘섭취부족, 조기 폐경 등에서 골다공증의 발생이 높아질 수 있으며, 뼈의 밀도가 감소하여 쉽게 골절이 될 수 있습니다.

관련 질환 골다공증, 골연화증

검사항목	2024
골밀도 검사	정상

남성정밀

전립선초음파검사는 전립선 암, 전립선 비대증 등 전립선의 형태적 이상 유무 및 크기를 측정합니다.
전립선 초음파 검사에서 이상이 없더라도 혈청 PSA가 상승되어 있거나 배뇨장애가 있을 시 비뇨기과적 진료가 필요합니다.

관련 질환 전립선비대

검사항목	2024
전립선초음파	특이소견없음

위·대장 내시경 및 조영술

위검사

위조영 검사는 바륨현탁액을 경구투여한 후에 엑스선 촬영을 하여 위와 십이지장의 모양 및 병변을 모니터로 직접 보면서 검사합니다. 검사는 10분 정도 소요되며, 용종, 위간질 종양, 위염, 위 ·십이지장궤양, 위암 등의 유무를 검사합니다.

위내시경 검사는 지속되는 복통, 메스꺼움, 구토, 연하곤란 등의 증상 진단 및 식도나 위·십이지장에 발생하는 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염 등 여러 종류의 질환을 진단하는 방법입니다. 상부 소화기계의 이상을 검사하기 위해 가장 정확하고 많이 쓰이는 검사입니다.

관련 질환 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염

검사항목	2024
위내시경	위식도역류질환, 만성표재성위염

대장검사

대장내시경 검사는 항문으로 내시경을 삽입하여 대장의 내부 및 소장의 일부까지 관찰하는 검사로 필요에 따라 지혈, 조직검사, 병변제거 등의 치료목적을 동반한 검사입니다.
대장암과 염증성 장질환의 진단에 매우 중요하며, 정상인의 경우 5년마다 1번정도 검사하고, 용종발견시 1~2년 이내에 재검사를 시행하도록 권합니다.

관련 질환 대장암, 염증성 장질환

검사항목	2024
대장내시경/조영촬영	정상범위(불완전검사)

초음파 검사

복부초음파 검사

복부초음파 검사는 간이나 담낭, 췌장, 신장, 비장 등의 진단에 필수적인 검사이며, 각종 암의 발견에 큰 효과가 있는 검사입니다.초음파는 인체에 해가 없고 통증이나 불편 없이 실시간으로 영상을 보면서 검사할 수 있습니다. 그러나 초음파의 특성상 볼 수 있는 장기에 한계가 있고 검사 받는 사람의 신체 특징, 장의 가스 등에 따라 검사 영역에 제한이 있을 수 있습니다. 특히 췌장은 체부와 꼬리 부분이 장내 공기에 막혀 보이지 않을 수 있습니다.

관련 질환 간암, 담낭암, 담석증, 췌장암, 신장결석, 신장암 등

검사항목	2024
상복부초음파	특이소견없음

특수장비 검사

• CT 검사

컴퓨터 단층촬영(CT)은 단순 X선 촬영과 달리 인체를 가로로 자른 여러 횡단면을 영상화합니다. 따라서 CT는 단순 X선 촬영에 비해 구조물이 겹쳐지는 것이 적어 구조물 및 병변을 좀 더 명확히 볼 수 있습니다.
CT-검사는 대부분의 장기 및 질환에서 병변이 의심되고 정밀검사를 시행해야 할 필요가 있을 때 기본이 되는 검사입니다.

검사항목	2024
뇌 CT	정상